KSW · UROLOGIE · PERIOPERATIVER PFAD

BENE Plattform

Kantonsspital Winterthur

Digitale Checkliste — präoperative Sprechstunde & Gesamtpfad

prä-/intra-/postoperativ

☎ Ansprechperson BENE-Nurse: Corina Frei · Stv. Jessica Ambros

Massnahmen, die ca. **2–3 Monate vor der Operation** in der BENE-Sprechstunde eingeleitet werden müssen. Kästchen antippen zum Abhaken, Werte direkt in die Felder eintragen.

☐ Vitalparameter erfassen

RR SYSTOLISCH (MMHG) | RR DIASTOLISCH (MMHG) | PULS (/MIN)

SPO2 (%) | TEMPERATUR (C) | GEWICHT (KG)

Freitext-Notiz…

FRAGEBÖGEN

☐ Fragebogen G8 (geriatrisches Screening)

- Bei tiefem Score: Zuweisung ad Geriatrie

G8-SCORE (0–17) | ZUWEISUNG GERIATRIE: –

Freitext-Notiz…

☐ Fragebogen NRS (Nutritional Risk Screening)

NRS-SCORE (0–7)

Freitext-Notiz…

☐ Fragebogen ECOG

ECOG PERFORMANCE STATUS: –

Freitext-Notiz…

☐ Fragebogen STOP-BANG

ANZAHL JA-ANTWORTEN (0–8)

Freitext-Notiz…

☐ Epworth Sleepiness Scale

EPWORTH-SCORE (0–24)

Freitext-Notiz…

☐ mMRC Dyspnoeskala

MMRC-GRAD

–

Freitext-Notiz…

LABOR (INKL. PBM)

☐ Laborwerte erfassen

LABORWERT	WERT	EINHEIT	
–		z.B. g/L	×

+ Laborwert hinzufügen

Freitext-Notiz…

ZUWEISUNGEN & MASSNAHMEN

☐ Anmeldung Anästhesie-Sprechstunde (PAB)

TERMIN-DATUM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

☐ Einleitung PBM gemäss Weisung „Perioperative Therapie von Anämie und Eisenmangel“

- Weisung: PBM-Standard (KSW-Portal)
- Details werden nach fachlicher Klärung gemäss Weisung ergänzt.

STATUS

–

ANSPRECHPERSON / NOTIZ

Freitext-Notiz…

☐ Überprüfung Zuweisung Kardiologie gemäss Weisung „Präoperative kardiale Abklärung“

- Zuweisung sobald Kriterien erfüllt, oder vorbekannt EF <50% oder mMRC Grad 3/4

EF (%)

MMRS

Freitext-Notiz…

☐ Raucheranamnese

- Nieraucher: keine Massnahmen
- Ex-Raucher >1 Jahr sistiert: Anbindung Rauchstopp-Sprechstunde bei Wunsch
- Raucher oder sistiert <1 Jahr: Anbindung Rauchstopp-Sprechstunde via KISIM „Anmeldung Pneumologie Sprechstunde“ → „Rauchstopp“

STATUS

–

ZIGARETTEN/TAG

PACK YEARS

SISTIERT SEIT (MM/JJJJ)

MM/JJJJ

Freitext-Notiz…

☐ Suchtmittelanamnese

ALKOHOL – WAS, WIE HÄUFIG?

DROGE / SUBSTANZ

HÄUFIGKEIT

z.B. täglich

BEMERKUNG

×

+ Droge hinzufügen

Freitext-Notiz…

☐ Zuweisung Pneumologie – OSAS-Abklärung

- Bei bekanntem NIV: Patient instruieren, OSAS-Gerät mitzubringen
- Zuweisung wenn STOP-BANG ≥3× Ja oder Epworth ≥11 — via KISIM „Anmeldung Pneumologie Sprechstunde“

BEKANNTES (O)SAS MIT NIV-THERAPIE?

–

Freitext-Notiz…

☐ Zuweisung Pneumologie – COPD / Asthma / Lungenfibrose / neuromuskulär

- COPD ab Gold I UND Kontrolle >1 Jahr ODER Verschlechterung
- Asthma symptomatisch/Verschlechterung ODER Kontrolle >1 Jahr
- Restriktive Lungenfunktion/Fibrose: Kontrolle >6 Monate → Anmeldung via KISIM „Lungenfunktion (LuFu)“

GRUNDERKRANKUNG | LETZTE KONTROLLE PNEUMOLOGIE | VERSCHLECHTERUNG?

– | tt.mm.jjjj | –

Freitext-Notiz…

☐ Anmeldung Ernährungsberatung

- Zuweisung wenn NRS ≥3 (siehe Fragebögen)
- Via KISIM Anmeldung „Ernährungstherapie/-beratung ambulant“ — Aufgebot innert 2 Wochen

TERMIN VEREINBART AM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

☐ Anmeldung Physiotherapie

- Alle Patient*innen: Anmeldung „Vita-Reha“ präoperativ via KISIM
- Falls Neoblase: zusätzlich „Beckenbodenphysiotherapie“
- Falls keine Reha/Kur geplant: zusätzlich „Vita-Reha“ postoperativ

NEOBLASE GEPLANT? | REHA/KUR BEREITS GEPLANT?

– | –

Freitext-Notiz…

☐ Vervollständigung Diagnosenliste

Freitext-Notiz…

☐ Vervollständigung Medikamentenliste

Freitext-Notiz…

☐ KISIM-Pfad verordnen

Freitext-Notiz…

- [ ] Postoperatives Management besprechen

- Reha → Kostengutsprache: „Arztzeugnis Nachsorge / Nachsorge- und Sozialberatung“, an Operateur zur Signatur
- Nach Hause mit Spitex → Mitteilung an Pflege: „bitte um Organisation Spitex nach Austritt“

GEWÄHLTE NACHSORGE

–

Freitext-Notiz…

- [ ] Patient über Thromboseprophylaxe informieren

- Bei eGFR <15 ml/min: Rücksprache mit Operateur
- Wenn bereits unter OAK/Marcoumar: nicht notwendig

PLAN / VERORDNUNG

EGFR (ML/MIN), FALLS RELEVANT

Freitext-Notiz…

- [ ] Termin beim Operateur 10–14 Tage vor Operation vorhanden?

TERMIN VORHANDEN?

–

TERMIN-DATUM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

- [ ] Information hochkalorischer Drink

- Am Vorabend der Operation: 400 ml (4×100 ml) — Ausnahme: Diabetiker*innen nicht
- Am Morgen, spätestens 2h präoperativ: 200 ml (2×100 ml)
- Abgabe und Instruktion am BENE-Termin

Freitext-Notiz…

- [ ] Planung Urinkultur

GEPLANTES DATUM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

Synthese aller Massnahmen entlang des Behandlungspfads — geordnet nach Phase und Berufsgruppe.

PHASE 1 **Präoperativ** 0/16

▾ **Urologie-Konsultation** — wenn möglich beim Operateur 0/6

☐ OP-Aufklärung

Freitext-Notiz…

☐ OP-Anmeldung

- In Rücksprache mit Operateur

Freitext-Notiz…

☐ BENE-Nurse informieren

- Per Telefon oder Mail informieren und Termin vereinbaren

TERMIN VEREINBART AM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

☐ Tumorboard (bei onkologischer Zystektomie)

TUMORBOARD-DATUM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

☐ Anmeldung Onkologie (bei onkologischer Zystektomie)

PERIOP. CHEMOIMMUNTHERAPIE GEPLANT?

–

ZUSTÄNDIGE/R ONKOLOGE/IN

Freitext-Notiz…

☐ Erneute Sprechstunde Urologie (10–14 Tage vor Zystektomie)

TERMIN-DATUM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

▾ **BENE/ERAS-Sprechstunde** — siehe Tab „Prä-OP Checkliste“

Wird im Tab «Prä-OP Checkliste» separat abgehakt.

Zur Prä-OP Checkliste →

▾ **Anästhesiologie** 0/1

- [ ] Checkliste / SOP Anästhesie Zystektomie durchführen

Freitext-Notiz…

▾ **Physiotherapie** — Anmeldung via BENE-Nurse 0/4

- [ ] Prä- und postoperative Vita-Reha

Freitext-Notiz…

- [ ] Kostengutsprache
  - Wird durch Physiotherapie gestellt — bei Ablehnung kontaktiert Physiotherapie den behandelnden Arzt

Freitext-Notiz…

- [ ] Beckenboden bei Neoblase

Freitext-Notiz…

- [ ] Präop Vita-Reha vs. einmalige Konsultation
  - Möglich 6–12 Wochen vor OP

GEWÄHLT

–

Freitext-Notiz…

▾ **Ernährungsberatung** — Anmeldung via BENE-Nurse 0/3

- [ ] Kann auch telemedizinisch durchgeführt werden

Freitext-Notiz…

- [ ] Optimierung Ernährung bei Malnutrition
  - Messung via NRS
  - Intervention ab NRS >3
  - Kostengutsprache für präoperatives Fresubin / Ernährungsoptimierung

  Freitext-Notiz…

- [ ] Keine Rezepte für High-Carb-Produkte

  Freitext-Notiz…

Stomaberatung — Anmeldung via BENE-Nurse 0/2

- [ ] Zeitpunkt und Anzahl Treffen individuell festlegen

  ANZAHL TREFFEN

  –

  Freitext-Notiz…

- [ ] Fakultatives Treffen bei Unsicherheit bezüglich Stoma

  Freitext-Notiz…

PHASE 2 Intraoperativ 0/3

Urologisch-operativ 0/1

- [ ] Antibiotische Prophylaxe

  Freitext-Notiz…

Anästhesie 0/1

- [ ] Checkliste / SOP Anästhesie Zystektomie durchführen

Freitext-Notiz…

Lagerungspflege 0/1

- [ ] SCDs immer
  - Wird durch Melanie Gaudin in der Anmeldung hinterlegt

Freitext-Notiz…

PHASE 3 Postoperativ stationär 0/31

Pflege — Meilensteine je Tag 0/5

- [ ] OP-Tag
  - Neben dem Bett gestanden / am Bettrand gesessen
  - Fresubin / klare Flüssigkeit wird vertragen
  - Kaugummi und Kaffee sobald genug wach
  - Schmerzen mit entsprechender Medikation tolerierbar

Freitext-Notiz…

- [ ] 1. postoperativer Tag
  - 4h ausserhalb des Bettes / 24h
  - Vollkost wird toleriert
  - Patient trägt eigene Kleidung
  - Schmerzen mit entsprechender Medikation tolerierbar

Freitext-Notiz…

- [ ] 2. postoperativer Tag
  - Instruktion Fragmin-Injektion erfolgt
  - 4 Ganglängen gelaufen
  - 6h ausserhalb des Bettes / 24h
  - Schmerzen mit entsprechender Medikation tolerierbar

Freitext-Notiz…

- [ ] Ab 3. postoperativem Tag

- Fortschritte beim Gehtraining
- Bei Neoblase: Instruktion „Blase anspülen“ erfolgt
- Kann Urinbeutel selbständig leeren
- Am Wochenende übernimmt Pflege die AktAss-Aufgaben gemäss Physio-Schema

Freitext-Notiz…

☐ Dokumentation

- Alles Obige in KISIM ärztlich oder pflegerisch (siehe Beispiel Pflegeprozess BENE Pankreas)

Freitext-Notiz…

▾ Physiotherapie 0/5

☐ Ab 1. postoperativem Tag Frühmobilisation mit Aktivitätsassistent

Freitext-Notiz…

☐ Physiotherapie ggf. bereits 1. POD, sonst 1–2× während Aufenthalt

Freitext-Notiz…

☐ Aktivitätsassistenz täglich

Freitext-Notiz…

☐ Mindestziele gemäss Plan Physiotherapie

- OP-Tag: Bettrand / kurze Strecke im Zimmer
- PO1 (evtl. +1): selbständig zimmermobil / ½ bis ganze Ganglänge in Begleitung
- PO2 (evtl. +1): ½ bis ganze Ganglänge selbständig / mehrere Ganglängen & Treppe in Begleitung
- PO3 (evtl. +1): selbständiges Gehtraining / MTT & Treppentraining mit AktAss
- Am Wochenende keine AktAss → Übernahme durch Pflege

Freitext-Notiz…

☐ Dokumentation erwünscht

Freitext-Notiz…

Ernährungsberatung 0/2

- [ ] Kostaufbau
  - Tag 1–3: Vollkost ¼ Portion
  - Besuch am 3. POD, dann Steigerung auf ½ Portion
  - Ziel: Vollkost ab 1. Tag

  Freitext-Notiz…

- [ ] Wunschkost
  - Kann nur verordnet werden, wenn Ernährungsberatung involviert ist

  Freitext-Notiz…

Stomaberatung 0/1

- [ ] Besuch während stationärem Aufenthalt

  Freitext-Notiz…

Ärztlich Urologie — Visite & Labor 0/5

- [ ] Visitendokumentation gemäss Vorlage

  Freitext-Notiz…

- [ ] Labortermine
  - 1. POD: Hb, K, Na, Kreatinin, Troponin
  - 2. POD: Hb, K, Na, Kreatinin, Mg, Troponin
  - 3. POD: Hb, Na, K, Kreatinin, Mg, CRP
  - 4. POD: Hb, Na, K, Kreatinin, Mg, CRP
  - Danach gemäss Operateur — Lactatanstieg im Rahmen der Operation ist zu erwarten

  Freitext-Notiz…

- [ ] Troponin-Kontrolle (V.a. periop. Myokardinfarkt)
  - Anstieg Troponin T hs >14 ng/L Tag 1/2 vs. präOP-Wert; ohne präOP-Wert: >70 ng/L oder An-/Abstieg >14 ng/L Tag1 vs. Tag2
  - Konsequenz: EKG und Konsil Kardiologie

TROPONIN PRÄOP (NG/L) | TROPONIN TAG 1 (NG/L) | TROPONIN TAG 2 (NG/L)

Freitext-Notiz…

- [ ] Transfusionsgrenze 90 g/L
  - Bei geplanter Transfusion ab höheren Werten: Rücksprache mit Operateur (negativer Einfluss auf Onkologie)

Freitext-Notiz…

- [ ] Kaliumziel hochnormal 4–4.5 mmol/L
  - Sobald Kalium <4 mmol/L: Start ≥60 mmol/24h Kalium i.v. bis Koststufe 2

Freitext-Notiz…

Ärztlich Urologie — Mikrobiologie & Thromboseprophylaxe 0/3

- [ ] Urinkultur aus Stomabeutel am 4. POD

Freitext-Notiz…

- [ ] Clexane
  - Start am OP-Tag 6h postoperativ, danach täglich (im KISIM inkl. Dosierung)
  - Insgesamt 4 Wochen postoperativ
  - Instruktion bis 2. POD erfolgt

Freitext-Notiz…

- [ ] Intermittierende pneumatische Kompression (SCD-Pumpe)
  - Solange auf IPS, danach Wechsel auf Thrombosestrümpfe bis Austritt

Freitext-Notiz…

Ärztlich Urologie — Analgesie & Kost 0/4

- [ ] Rectus-Sheath-Katheter gemäss SOP

Freitext-Notiz…

- [ ] PDA-Katheter
  - Ca. 72h postoperativ gemäss Anästhesie

Freitext-Notiz…

- [ ] Basisanalgesie i.v. oder p.o.
  - Novalgin, Dafalgan, NSAR
  - Wenn immer möglich keine Opiate — NRS 3/10 akzeptieren, erst bei ausgeschöpfter Basisanalgesie

Freitext-Notiz…

- [ ] Kost- und Medikamentenplan
  - Freie Flüssigkeit schluckweise am OP-Tag, Kaugummi/Kaffee sobald wach
  - Vollkost ab 1. postoperativem Tag; Magnesiocard 5 mmol 1-0-0-0 p.o.; Kalium gemäss Labor
  - Pantoprazol 40 mg i.v., ab 2. POD p.o. bis Austritt
  - Freka Klyss durch Arzt am 2. POD wenn noch kein Stuhlgang; medikamentöse Darmstimulation
  - Tägliche Gewichtsmessung, Bilanz immer, Bilanzziel ± 0 ml
  - Keine reguläre antibiotische Prophylaxe

Freitext-Notiz…

Ärztlich Urologie — Drainagen & Urostoma

0/2

- [ ] Ureterkatheter beidseits
  - Links mit schräger Spitze — Fördermenge kontrollieren, bei Bedarf anspülen mit 2–4 ml, 1×/Schicht

Freitext-Notiz…

- [ ] Urostoma-Management
  - Urinkultur aus Stomabeutel am 3. POD
  - Bei Austritt am 5. POD: Entfernung UK rechts am 5. und UK links am 6. POD unter resistenzgerechter Therapie oder Bactrim p.o.
  - Bei früherem Austritt: Entfernung nach 7–14 Tagen beim Operateur — Sonographie, resistenzgerecht oder empirisch 1× Bactrim p.o. bei negativer Urinkultur

ENTFERNUNG UK RECHTS (DATUM)

tt.mm.jjjj

ENTFERNUNG UK LINKS (DATUM)

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

Ärztlich Urologie — Austrittsbericht 0/1

- [ ] Diagnosen überprüfen (CW-relevant)
  - Postoperatives Delir
  - Akute Nephritis mit Keimen (a.e. Pyelonephritis nach Zug Mono-J-Katheter)
  - Karzinom als Hauptdiagnose
  - Blutungsanämie mit Massnahmen / Suche nach Blutungsquelle
  - Alle Erreger dokumentieren

Freitext-Notiz…

Ärztlich IPS 0/2

- [ ] MAP mindestens 65 mmHg halten

Freitext-Notiz…

- [ ] Volumenplus vermeiden
  - Grosszügig Vasopressoren nutzen (reduziert Komplikationen um ca. 50%, Wuethrich et al., Anesthesiology 2014)
  - Erhöhung der Volumengabe nur nach Rücksprache mit Oberarzt IPS oder Operateur

Freitext-Notiz…

Ärztlich Anästhesie / Schmerzdienst 0/1

- [ ] Bei PDA: Laufrate nach Schmerzen anpassen
  - Nicht zu früh reduzieren nur zur Blutdruckoptimierung

Freitext-Notiz…

PHASE 4 Postoperativ ambulant 0/8

Ärztlich 0/3

- [ ] Thromboseprophylaxe für 4 Wochen postoperativ fortführen

Freitext-Notiz…

- [ ] Bei Ileum-Conduit
  - Bei Austritt am 5. POD: Entfernung UK nach 7–14 Tagen beim Operateur — Sonographie, resistenzgerecht oder empirisch 1× Bactrim p.o. bei negativer Urinkultur

ENTFERNUNG UK (DATUM)

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

- [ ] Bei Neoblase
  - Urinkultur aus Pouchkatheter (Hausarzt oder Urologie)
  - Re-Hospitalisation für 1 Nacht zur Inbetriebnahme der Neoblase, unter resistenzgerechter Therapie gemäss Kultur
  - Zystographie, vBGA vor Katheterzug und am Morgen danach

RE-HOSPITALISATION (DATUM)

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

Physiotherapie 0/3

- [ ] Vita-Reha analog präoperativ, falls keine Reha geplant

Freitext-Notiz…

- [ ] Booklet analog präoperativ

Freitext-Notiz…

- [ ] Bei Neoblase: postoperativ Beckenboden

Freitext-Notiz…

Stomaberatung 0/1

- [ ] Termine postoperativ festlegen

TERMIN-DATUM

tt.mm.jjjj

Freitext-Notiz…

Ernährungsberatung 0/1

- [ ] Nach Hospitalisation aktuell nicht vorgesehen

Freitext-Notiz…